

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 ноября 2021 г. N 1108н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫЯВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЧАЕВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НОМЕНКЛАТУРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЯВЛЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Инфекционное заболевание пациента является инфекцией (инфекционной болезнью), связанной с оказанием медицинской помощи (далее - ИСМП), в случае соответствия следующим критериям:

- 1) является клинически распознаваемым, в том числе с учетом результатов лабораторных исследований;
- 2) возникло у пациента в результате его поступления в медицинскую организацию или обращения за оказанием медицинской помощи вне зависимости от времени появления симптомов заболевания;
- 3) связано с оказанием медицинской помощи;
- 4) отсутствовало у пациента при госпитализации или обращении за оказанием медицинской помощи в медицинскую организацию, в том числе в инкубационном периоде заболевания, кроме случаев инфекций (инфекционных болезней), связанных с предшествующей госпитализацией или предшествующим обращением за оказанием медицинской помощи в медицинскую организацию;
- 5) не является закономерным продолжением патологического процесса, имевшегося у пациента при госпитализации или обращении за оказанием медицинской помощи;
- 6) не является обострением хронического инфекционного заболевания, имевшегося у пациента при госпитализации или обращении за оказанием медицинской помощи.

2. Инфекционное заболевание работника медицинской организации является ИСМП в случае соответствия следующим критериям:

- 1) является клинически распознаваемым, в том числе с учетом результатов лабораторных исследований;
- 2) возникло у работника медицинской организации при выполнении трудовых обязанностей в результате профессиональной деятельности;
- 3) связано с оказанием медицинской помощи;
- 4) не выявлено у работника при поступлении на работу <1> в данную медицинскую организацию, в том числе в инкубационном периоде заболевания;

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2021 г., регистрационный N 62277) (далее - Приказ Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 28 января 2021 г. N 29н).

5) не является обострением хронического инфекционного заболевания, имевшегося у работника до начала работы.

Расследование и учет профессиональных заболеваний работников медицинской организации проводятся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <2>.

<2> Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5149; 2020, N 30, ст. 4898).

3. В медицинской организации осуществляется разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и снижение распространения ИСМП в медицинских организациях (далее - мероприятия по профилактике ИСМП), проведение противоэпидемических мероприятий, выявление случаев ИСМП, проведение эпидемиологического расследования каждого предполагаемого случая ИСМП и регистрация выявленных случаев ИСМП, определение причин и условий возникновения случаев ИСМП, анализ заболеваемости ИСМП.

4. Профилактика ИСМП включает следующие мероприятия:
снижение риска заноса возбудителя инфекционных болезней в медицинскую организацию и предотвращение возникновения условий для формирования внутрибольничных штаммов микроорганизмов, а также штаммов, обладающих устойчивостью к противомикробным лекарственным препаратам, химическим и (или) биологическим средствам;
обеспечение эпидемиологической безопасности внешней среды медицинской организации;
предотвращение распространения (выноса) инфекционного заболевания за пределы медицинской организации;
обеспечение соответствия медицинской организации санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также условиям деятельности медицинской организации <3>;

<3> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61953).

проведение оценки риска возникновения случаев ИСМП у пациента и принятие мер по его минимизации;

проведение лечебно-диагностических мероприятий для выявления и лечения пациентов с ИСМП; обеспечение пребывания пациента в условиях изоляции (при необходимости) <4> и оказания ему медицинской помощи;

проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекционного заболевания <4>;

проведение микробиологического мониторинга <4> циркулирующих микроорганизмов с определением резистентности к противомикробным лекарственным препаратам, химическим и (или) биологическим средствам;

проведение противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц <4>;

<4> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2021 г., регистрационный N 62500) (далее - СанПин 3.3686-21).

проведение микробиологических исследований биологического материала пациентов, медицинских работников (включая случаи подозрения и (или) возникновения ИСМП) и объектов внешней среды медицинской организации <5>;

<5> Правила проведения лабораторных исследований, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2021 г. N 464н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2021 г., регистрационный N 63737).

проведение дезинфекционных, стерилизационных мероприятий в медицинской организации <6>; обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских технологий, применяемых в медицинской организации, в том числе соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств <6>;

<6> СанПин 3.3686-21; Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 785н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный N 60192) (далее - Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности).

соблюдение правил гигиены рук в медицинской организации, наличие оборудованных мест для мытья и обработки рук;
предупреждение случаев ИСМП у работников медицинских организаций <7>;

<7> СанПин 3.3686-21; Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности; медицинской деятельности; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.

рациональное применение противомикробных лекарственных препаратов, химических и (или) биологических средств для профилактики и лечения заболеваний и (или) состояний.

5. Организация мероприятий по профилактике ИСМП осуществляется врачом-эпидемиологом, эпидемиологическим отделом медицинской организации, лицом, уполномоченным руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, Комиссией по профилактике ИСМП (далее - Комиссия).

6. Проведение мероприятий по профилактике ИСМП и обеспечению эпидемиологической безопасности медицинской деятельности осуществляется медицинскими и иными работниками медицинской организации в рамках исполнения должностных обязанностей.

7. Для контроля за проведением мероприятий и координации действий медицинских и иных работников медицинской организации по профилактике ИСМП в медицинской организации создается Комиссия, которая осуществляет следующие функции:

проводит анализ заболеваемости ИСМП, анализ потенциального и реализованного риска ИСМП и формирует рекомендации по профилактике ИСМП в медицинской организации;

оценку качества, полноты и своевременности профилактических и противоэпидемических мероприятий;

проводит оценку причин и условий возникновения единичного или групповых случаев ИСМП;

осуществляет формирование комплекса необходимых мер <8> для ликвидации эпидемической ситуации и предотвращения возникновения случаев ИСМП;

<8> СанПин 3.3686-21.

рассматривает подготовленную врачом-эпидемиологом, эпидемиологическим отделом или лицом, уполномоченным руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, программу профилактики ИСМП и рекомендует ее к утверждению в медицинской организации.

Комиссия создается на основании приказа руководителя медицинской организации до 30 января текущего года.

Председателем Комиссии назначается руководитель или заместитель руководителя медицинской организации.

В состав Комиссии включаются врач-эпидемиолог, главная (старшая) медицинская сестра, заведующие структурными подразделениями, врач-бактериолог, врач-клинический фармаколог, врач-инфекционист, врач-патологоанатом и другие работники медицинской организации.

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом, утверждаемым руководителем медицинской организации. Форма проведения заседаний Комиссии определяется руководителем медицинской организации.

Комиссия с целью реализации своих задач и выполнения функций может запрашивать у работников медицинской организации письменные и устные объяснения по существу рассматриваемых вопросов, вносить предложения по снижению риска возникновения случаев ИСМП, необходимым противоэпидемическим мероприятиям, по материально-техническому обеспечению для профилактики ИСМП.

Решение Комиссии оформляется протоколом.

Председатель Комиссии ежеквартально и по итогам года представляет руководителю медицинской организации письменный отчет о работе Комиссии.

Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет руководитель медицинской организации.

8. Ответственность за организацию и проведение мероприятий по профилактике ИСМП возлагается на руководителя медицинской организации.

9. Руководителем медицинской организации в целях выявления и регистрации случаев ИСМП в медицинской организации устанавливаются:

перечень состояний и нозологических форм заболеваний ИСМП, подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации, на основе номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации, утвержденной настоящим Приказом (приложение N 2 к настоящему Приказу), с учетом вида медицинской организации, профиля, условий и форм оказания медицинской помощи;

стандартные операционные процедуры по выявлению и регистрации случаев ИСМП, в том числе алгоритмы действий медицинских работников при выявлении случаев ИСМП, порядок передачи

информации о выявлении и регистрации случаев ИСМП в медицинской организации;
порядок представления руководителю медицинской организации информации об анализе заболеваемости ИСМП.

10. Информация о подозрении на случай ИСМП при выявлении незамедлительно подается медицинским работником структурного подразделения медицинской организации врачу-эпидемиологу, в эпидемиологический отдел, лицу, уполномоченному руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).

11. На основании полученной информации о подозрении на случай ИСМП проводится эпидемиологическое расследование предполагаемого случая ИСМП, которое осуществляется врачом-эпидемиологом, эпидемиологическим отделом медицинской организации, лицом, уполномоченным руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

12. Случай инфекционного заболевания определяется как ИСМП на основе совокупности клинико-анамнестических, лабораторных, инструментальных и эпидемиологических данных, по результатам эпидемиологического расследования с учетом критериев, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка.

13. Информация о выявленных случаях ИСМП учитывается и анализируется в рамках мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комиссией (Службой) по внутреннему контролю и (или) уполномоченным лицом по качеству и безопасности медицинской деятельности <9>.

<9> Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

О случае ИСМП передается экстренное извещение в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

14. Анализ заболеваемости ИСМП в медицинской организации осуществляется врачом-эпидемиологом, эпидемиологическим отделом медицинской организации, лицом, уполномоченным руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, Комиссией на основе результатов эпидемиологического мониторинга, микробиологического мониторинга, мониторинга проведения инвазивных процедур, оценки факторов риска возникновения и распространения ИСМП в медицинской организации.

15. Оценка качества проведения мероприятий по профилактике ИСМП осуществляется путем плановых и целевых (внеплановых) проверок медицинской организации в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комиссией (Службой) по внутреннему контролю и (или) уполномоченным лицом по качеству и безопасности медицинской деятельности <9>.

16. В целях повышения эффективности выявления и регистрации случаев ИСМП, а также улучшения качества профилактических мероприятий медицинские работники с высшим образованием и средним профессиональным образованием проходят обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам эпидемиологии и профилактики ИСМП со сроком обучения не реже 1 раза в 3 года не менее 36 часов.

НОМЕНКЛАТУРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЯВЛЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I.	Клинические (нозологические) группы инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами	Коды по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10)
	Инфекции области хирургического вмешательства	A48.0; T79.3; T81.4; T82.6; T82.7; T83.5; T83.6; T84.5 - T84.7; T85.7; T87.4; T88.8; G04.2; G04.8; G04.9 Другие коды <u>МКБ-10</u> нозологических форм в соответствии с областью хирургического вмешательства (J85; J86; K65; N98.0; O04.0; O04.5; O07.0; O08.0 и другие)
	Инфекции органов дыхания	J15.0 - J15.6; J15.8; J15.9; J16; J18; J20 - J22; T88.0
	Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, иммунизацией, в том числе катетер-ассоциированные инфекции кровотока	A40; A41; I80; T80.2; T.82.6; T.82.7; T88.0; R65.0; R65.1; Y71.2
	Инфекции мочевыводящих путей	N30.0; N34.0; N39.0; T83.5; T83.6; T81.4
	Гнойно-септические инфекции новорожденных	G00; I80.8; J15.0 - J15.6; J15.8; J15.9; J16; J18; J20 - J22; L00; L01; L02; L03; L08.0; L08.8; L08.9; M86.0 - M86.2; M86.8; M86.9; P36; P38; P39; T80.2; T83.5
	Гнойно-септические инфекции родильниц	O85; O86; O90.0 - O91.1; O99.5; O75.3
II.	Нозологические формы инфекционных болезней, вызываемые патогенными микроорганизмами, и паразитарных болезней	Коды по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10)
	Острые кишечные инфекции, острые вирусные гепатиты А, Е	A01; A03; A04; A05; A08; A09; B15; B17.2
	Другие сальмонеллезные инфекции	A02
	Воздушно-капельные инфекции	A36; A37; A39; B01; B05; B06; B26; J06; J09 - J11; J22
	в том числе корь	B05
	Туберкулез впервые выявленный, активные формы	A15 - A19
	Болезнь, вызванная ВИЧ	B20 - B24
	Вирусный гепатит В	B16
	Вирусный гепатит С	B17.1
	COVID-19	U07.1; U07.2
	Пневмонии (вирусные, бактериальные, вызванные иными возбудителями,	J12 - J18

неуточненные)	
Другие инфекционные заболевания, носительство возбудителей инфекционных заболеваний	обозначаются кодами по <u>МКБ-10</u> , соответственно нозологической форме